

AFMCP 4장 — 임상검진 Part4 핵심 요약

공통 패턴 통합 | Dr. Stone & Dr. Boham

영양 부족 패턴 — 빠른 참조표

- 단백질 부족: 저근육량·탈모·부서지는 손발톱; GLP-1 사용자·소화 불량 환자 주의; 청소년 허약함도 포함
- 필수 지방산(EFA) 부족: 청소년 여드름, 팔 뒤 모공각화증, 부서지는 손발톱; 밤 관절 통증 스크리닝
- 마그네슘 부족: PAC·PVC·경련·진전; 근육 경련·변비; 혈청 목표 2.5~3.5; Ca-K 교정 실패 시 먼저 확인
- 아연 부족: 여드름·탈모·설사·설염·사마귀·재발 감염; 야간 시력 저하; 10mg/L 설사로 손실
- 비타민 A 부족: 야간 시력·눈 맞춤 저하; 장벽·점막 손상; BCMO SNP 시 카로틴 전환 불가; A·D·E·K 함께 보충
- 비타민 B12 부족: 신경병증·우울·인지 저하·허 통증·피부 변화; 목표 혈청 500 이상; MMA·호모시스테인 병행
- 비타민 B6: 결핍 = 말초 신경병증·우울·경련 / 과잉 = 통증성 신경병증

핵심 임상 스크리닝 질문

- 「밤에 관절 통증으로 잠이 깨나요?」 → EFA 부족 스크리닝
- 「밤에 시야가 어두운가요?」 → 아연 부족 스크리닝 (비타민 A 망막 활성화)
- 「허가 아픈가요?」 → B12·B6 부족 스크리닝
- 「의자에서 일어날 때 힘든가요?」 → 단백질 부족·근감소증 스크리닝

특별 주의 사항

- GLP-1 수용체 작용제 사용 시 단백질 부족·근감소증 위험 → 필수 모니터링
- 마그네슘이 없으면 칼슘·칼륨은 교정되지 않음
- 비타민 A·D·E·K는 공유 수용체 → 단독 보충보다 복합 보충 권장
- 아연은 비타민 A를 망막에서 활성화 → 둘을 함께 평가
- B12 혈청 검사 + MMA + 호모시스테인 3종 병행 — 하나씩 놓칠 수 있음